ODO-EST01 | Edición 03 | Revisión: 09/10/2026

Manual integral de reprocesamiento y esterilización

Objetivo

Establecer una secuencia verificable para manual integral de reprocesamiento y esterilización, articulada con la oferta y los recursos reales del consultorio.

Alcance y responsabilidades

Aplicación en odontologia ambulatoria, dentro de competencia y modalidad habilitada. Responsable clínico o del proceso: asignar en la adopción; personal de apoyo actúa según rol y entrenamiento. Confirmar aplicabilidad al prestador y sede antes de adoptar.

Términos de uso

Criterio: condición que se verifica. Evidencia: soporte auténtico de lo realizado. No conformidad: diferencia frente al criterio aplicable. Contención: medida inmediata para impedir daño. Cierre: corrección cuya eficacia se comprobó. Los términos clínicos/técnicos particulares se interpretan conforme a la guía o manual indicado.

Organización

Asignar responsable entrenado, suplente y límites de tarea. Identificar cada dispositivo reutilizable y disponer de instrucciones; separar punto de uso, recepción sucia, limpieza, inspección/empaque, esterilización y almacenamiento limpio. El flujo debe evitar retorno contaminado; completar plano local, horarios y capacidad.

Ruta completa

1. En punto de uso, retirar residuos gruesos con método seguro y evitar secado de suciedad según fabricante; enviar en recipiente cerrado resistente identificado.

2. Recibir y reconciliar instrumentos; limpiar con EPP resistente y método compatible, enjuagar y secar. Inspeccionar limpieza y función; devolver a lavado si suciedad.

3. Empacar con barrera compatible, rotular lote/carga y colocar indicadores; seleccionar ciclo compatible y cargar conforme a manual.

4. Registrar controles físicos, químicos y biológicos aplicables; esperar enfriamiento seguro y decidir liberación documentada. No liberar paquete húmedo, dañado, incompleto o con falla.

5. Almacenar protegido, controlar integridad y vincular paquete/carga con paciente y procedimiento. Ante falla, cuarentena, investigación y retiro con trazabilidad.

Límites

No esterilizar desechables ni material incompatible. No sustituir lavado por autoclave o indicadores; un indicador cambia por exposición, no prueba por sí solo esterilidad. No usar esterilización inmediata sin envoltura para compensar falta de inventario.

Evidencia

Anexar fabricantes, clasificación, programas autorizados, calificación, mantenimiento, competencia y registros. Revisar Resolución 2183 vigente al corte y transición 914/2025 a partir del 3 de enero de 2027; diferenciar consultorio exceptuado de central. La entrega es manual local propuesto, no certificado técnico.

Aplicación paso a paso y respuesta a desviaciones

Antes de ejecutar

Verificar identificación del dispositivo/equipo, clasificación, compatibilidad del fabricante y estado de mantenimiento. Determinar zona sucia o limpia y barreras requeridas. Confirmar suministro de agua, detergente, barreras e indicadores apropiados y capacidad para completar el flujo sin improvisación. Si instrucción o compatibilidad faltan, detener y escalar al responsable.

Durante la tarea

Mantener segregación y código rastreable. Registrar parámetros y resultados propios de la etapa: limpieza, secado, inspección, sello, programa o control. Una etapa correcta no compensa otra fallida. No introducir material sucio en área limpia, liberar sin revisión ni mezclar paquetes retenidos con disponibles.

Criterio de detención

Suciedad residual, daño, empaque húmedo/roto, ciclo incompleto, control no satisfactorio o trazabilidad perdida obligan a retener lo afectado y evaluar extensión. Identificar cuarentena, conservar evidencia, restringir equipo/proceso si procede y localizar cargas relacionadas; el instrumental no se usa para comprobar su condición.

Corrección y retorno

Determinar causa, etapa a la que debe retornar el material, necesidad de barrera nueva y pruebas técnicas. Registrar nueva carga/vínculo cuando reprocesa. Retorno de equipo tras falla mayor requiere soporte y controles aplicables; no basta encenderlo o obtener cambio de color.

Auditoría de trazabilidad

Seleccionar una carga real y recuperar programa, parámetros, controles, liberación, paquetes y pacientes cuando corresponde. Consultar también en sentido inverso. Evaluar registros legibles, archivo de resultados, control positivo BI, condiciones de almacenamiento y seguimiento de incidencias.

Frecuencia y puntos de control

Ejecutar en cada atención, tarea o cambio que active este proceso. Definir periodicidad de revisión por riesgo, oferta, fabricante y norma aplicable; registrar la programación local. La periodicidad local no se presenta como exigencia legal universal.

Registros relacionados

Usar los formatos individuales vinculados al código ODO-EST01 en el índice maestro. Asociar fecha, responsable, resultado y ubicación de evidencia. Las historias y consentimientos diligenciados se mantienen en expediente reservado; los soportes administrativos no deben exponer datos clínicos.

Verificación, fundamento y adopción

Indicador y método de evaluación

Indicador local propuesto: ejecuciones verificadas con pasos críticos completos / ejecuciones revisadas × 100. Definir periodo, muestra, fuente y meta según riesgo. Con denominador cero anotar no calculable. Registrar además oportunidad y gravedad de desviaciones; no interpretar ausencia de reporte como ausencia de daño.

Acciones correctivas

Describir hallazgo concreto, medida inmediata, causa, acción, responsable y plazo. Verificar eficacia con evidencia posterior antes de cerrar. Si existe riesgo activo o falta competencia/recurso, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa segura.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Odontología

Ley 35 de 1989 y Decreto 491 de 1990: ética, ejercicio e información para la decisión clínica. El procedimiento debe estar dentro de competencia y oferta real.

https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166609

Reprocesamiento

Resolución 2183 de 2004 y criterios vigentes de habilitación; Resolución 914 de 2025 y manual DMER: vigencia general prevista 03/01/2027 conforme al artículo 15. Revisar transitoriedad del artículo 12 y reglas específicas del tipo de prestador.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_0914_2025.htm

Fuentes técnicas particulares

Consultar versión íntegra y vigente, población y metodología; adaptar con trazabilidad. Una referencia técnica orienta práctica y no es legislación colombiana.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2183-de-2004.pdf ;
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/manual-practicas-reprocesamiento-dmer.pdf ;
https://www.cdc.gov/dental-infection-control/hcp/dental-ipc-faqs/sterilization-monitoring.html ;
https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_0914_2025.htm

Soportes auténticos que deben anexarse

Adjuntar documentos de autoridad, títulos/licencias, guías completas, instrucciones del fabricante, contratos o registros reales que correspondan al contenido. No se producen certificados, mantenimientos, planos técnicos ni evidencias de ejecución ficticias.

Adopción y actualización

Completar responsables, recursos, límites y registros; aprobar con autenticación válida y capacitar antes de utilizar. Revisar ante cambio normativo, incidente, tecnología o población. El encabezado permanece vacío para personalización; el contenido es propuesta y no acredita por sí mismo cumplimiento.